

Une femme nulligeste de 25 ans avec des cycles menstruels de 40 à 60 jours vous consulte car elle souhaite une grossesse. Elle ne prend aucun médicament.

Le bilan étiologique met en évidence un **microprolactinome** non accessible à un traitement chirurgical.

Quel traitement est à envisager en premier lieu ?

- A: Un agoniste de la dopamine
- B: Un agoniste de la GnRH
- C: La GnRH
- D: Le clomifène
- E: Un oestro-progestatif pour régulariser le cycle menstruel

Une femme de 43 ans vous consulte pour un contrôle gynécologique. Selon les renseignements qu'elle vous fournit, son dernier contrôle effectué 8 ans auparavant ne révélait aucune anomalie.

Vous effectuez un frottis de dépistage du cancer du col.

Le résultat de l'examen du frottis est le suivant: "Highgrade squamous intraepithelial lesion (H-SIL) selon Bethesda, dysplasie marquée, suspicion de carcinome in situ".

Laquelle des démarches suivantes est indiquée ?

- A: Convoquer la patiente dans 3 mois pour renouveler le frottis
- B: Prescrire un traitement local de l'inflammation vaginale et répéter le frottis après la fin de ce traitement
- C: Demander un examen d'imagerie complémentaire (CT ou IRM)
- D: Convoquer sans délai la patiente pour réaliser une colposcopie et des biopsies cervicales dirigées
- E: convoquer sans délai la patiente et lui conseiller une hystérectomie d'emblée

P 547142	Q
Source: Quizzit	Catalogue
Question type	Options
Single Choice	1

Une femme de 40 ans présente des hémorragies de privation régulières sous contraception hormonale à prédominance gestagénique. Vous palpez dans la région annexielle droite une masse mobile, indolore, aux contours réguliers et d'un diamètre de 10 cm. Une échographie abdominale montre la présence d'un kyste multiloculaire.

Quelle est la prise en charge optimale ?

- A: une exploration chirurgicale
- B: un frottis cytologique du col utérin avec curetage utérin explorateur
- C: un contrôle ultrasonographique dans 3 mois puis annuel pour surveiller l'évolution
- D: un traitement cytostatique
- E: ni investigation complémentaire ni traitement, mais seulement un contrôle annuel

Une femme de 33 ans se plaint d'une leucorrhée abondante depuis 4 jours, de douleurs abdominales basses et d'un état fébrile autour de 38 °C. Vous suspectez une infection génitale.

Lequel des micro-organismes suivants faut-il rechercher en priorité?

- A: *Candida albicans*
- B: *Gardnerella vaginalis*
- C: *Chlamydia trachomatis*
- D: Herpès-virus de type II
- E: *Bacteroides fragilis*

Chez les femmes sous oestroprogestatifs combinés, lequel de ces médicaments peut diminuer l'efficacité de la contraception?

- A: les antitussifs
- B: les antiémétiques
- C: les glucocorticoïdes
- D: les antiépileptiques
- E: les préparations à base de fer

Une patiente de 22 ans consulte en urgence pour des douleurs abdominales qui ont débuté il y a 3 heures. La douleur est décrite comme généralisée et crampiforme. Dans un premier temps, la patiente a pensé à un début de règles mais elle consulte car les saignements sont plus abondants qu'un premier jour de règles. Ses dernières règles remontent à environ 4 semaines. Elle est sexuellement active avec des partenaires multiples sous contraception par préservatifs. Elle est afebrile, TA 115/65 mmHg, Pouls 80/min. L'abdomen est souple sans péritonisme mais la palpation profonde de la région sus-pubienne est sensible. L'examen gynécologique montre la présence de sang au niveau vaginal, le col est fermé. La palpation utérine est sensible et l'utérus semble augmenté de taille, les annexes sont normales. Le test de grossesse urinaire est positif.

Quelle est l'étape suivante la plus appropriée:

- A: Effectuer un curetage pour une fausse-couche
- B: Effectuer une laparoscopie pour une suspicion de GEU
- C: Demander un groupe sanguin avec rhésus et effectuer une échographie pelvienne
- D: Prescrire une antibiothérapie pour une infection gynécologique haute
- E: Prescrire du méthotrexate pour une grossesse extra-utérine

Patiente de 28 ans qui consulte pour des démangeaisons et des pertes vaginales. Ses symptômes ont débuté il y a 2 jours et sont en augmentation. Elle se plaint également d'une algurie. Elle est en bonne santé habituelle elle a été traitée par antibiothérapie il y a peu de temps pour une sinusite. L'examen status révèle un érythème et un œdème vulvaire associé à des leucorrhées abondantes. L'examen direct montre des pseudo-hyphes.

La prise en charge la plus appropriée est:

- A: Effectuer un lavage vaginal par ampicilline
- B: Effectuer une biopsie vulvaire
- C: Prescrire de l'azithromycine orale
- D: Prescrire un traitement topique de clotrimazole
- E: Traiter avec du métronidazole topique

Patiente de 58 ans qui présente des bouffées de chaleur apparues il y a 6 mois en augmentation récente. Elles surviennent à différents moments de la journée mais sont plus intenses la nuit. Ses dernières règles remontent à environ 7 mois. Elle est connue pour un antécédent d'embolie pulmonaire et de dépression. Elle est sous sertraline et fume un paquet de cigarettes par jour. Le status général et gynécologique est sans particularité. La phytothérapie n'a produit aucun effet.

Le traitement médicamenteux le plus approprié est :

- A: Clonidine
- B: Œstrogène et progestérone
- C: Œstrogènes seuls
- D: Raloxifène
- E: Tamoxifène

Patiente de 72 ans qui consulte pour un prurit vulvaire s'aggravant depuis 3 ans. Elle a été traitée à plusieurs reprises par des antifongiques. Elle n'a pas présenté de métrorragie depuis sa ménopause apparue à l'âge de 54 ans. Elle fume un paquet de cigarettes par jour. A l'examen vulvaire, on remarque la présence d'une lésion ulcérée de la grande lèvre gauche de 2 cm. Le reste de l'examen est normal.

L'attitude la plus appropriée est:

- A: Biopsie de la lésion vulvaire
- B: Proposer une vulvectomie d'emblée
- C: Prescrire une antibiothérapie à large spectre
- D: Prescrire une crème à base de stéroïdes
- E: Référer à un psychiatre

Patiente de 31 ans qui consulte en urgence pour des douleurs abdominales présentes depuis 36h, associées à un spotting. Elle n'a pas d'ATCD médico-chirurgicaux. La date de ses dernières règles est imprécise. Au status: T°:37°, TA: 116/78, Pouls: 82/min. Son abdomen est souple et indolore. Présence de sang en faible quantité au niveau vaginal, le col est fermé, il n'y a pas de masse palpable mais une sensibilité à la palpation bimanuelle de la région annexielle gauche. Le laboratoire ne montre pas de leucocytose, pas d'anémie et les thrombocytes sont normaux.

Que proposez-vous en premier lieu comme examen complémentaire ?

- A: Un Ct-scanner abdomino-pelvien
- B: Une RX abdominale
- C: Un ECG
- D: Un dosage sanguin des hCG
- E: Une échographie pelvienne

Patiente de 16 ans qui consulte inquiète de ne pas encore avoir eu ses règles. Elle n'a pas d'autre problème médical et n'a pas encore eu de rapport sexuel. Sa mère et sa sœur ont eu leurs premières règles à l'âge de 13 ans avec des cycles réguliers. Sa TA est 110/70 mmHg. Elle ne présente aucune douleur abdominale. Elle mesure 155 cm pour 49 kg (absence de retard statural). L'examen physique révèle des seins de développement normal pour l'âge et sa pilosité pubienne et axillaire est normale.

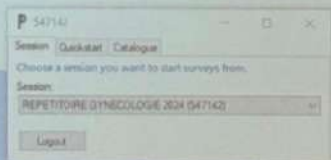
Sa cause d'aménorrhée primaire la plus probable est:

- A: Une dysfonction hypothalamique
- B: Une imperforation hyménéale
- C: Une dysfonction hypophysaire
- D: Un syndrome de résistance aux androgènes
- E: Une malformation utéro-vaginale

Patiente de 26 ans en BSH qui consulte pour une dysménorrhée sévère évoluant depuis 6 mois. Elle ne présente pas de métrorragies. Sa ménarche remonte à l'âge de 14 ans qui s'est suivie de cycles réguliers. Elle se traite par anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont peu efficaces. Elle a des rapports sexuels protégés et n'a pas d'antécédents de maladie sexuellement transmissible. Au status, elle est afébrile, l'examen pelvien est normal. L'échographie endovaginale est sans particularité à l'exception d'un kyste ovarien droit.

L'anamnèse est évocatrice :

- A: D'une endométriose
- B: D'une endométrite
- C: D'une infection gynécologique haute
- D: D'une rupture de kyste ovarien
- E: D'un fibrome utérin



Patiente de 32 ans qui présente des hyperménorrhées depuis 3 mois associées à des métrorragies occasionnelles. Elle ne présente pas de dysménorrhée ou de douleur abdominale. Depuis l'âge de 14 ans, elle a des cycles habituellement réguliers. Le laboratoire révèle une anémie microcytaire hypochrome. La crase est normale.

L'origine la plus probable de ces symptômes est:

- A: Des saignements sur cycles anovulatoires
- B: Une coagulopathie
- C: Une hyperplasie de l'endomètre
- D: Un polype endométrial
- E: Une fausse couche

Patiente de 37 ans, 4G 4P qui consulte pour une demande de contraception. Elle souhaite un moyen de contraception sûr et le plus « naturel » possible. Son planning familial est terminé. Elle souffre de BPCO sur tabagisme; elle fume 2 paquets de cigarettes par jour depuis 14 ans. Elle n'a pas d'ATCD chirurgical. Elle a une relation stable avec son conjoint depuis 10 ans. Le status est sans particularité.

Quel moyen de contraception lui proposez-vous en première intention ?

- A: Préservatifs
- B: Un stérilet
- C: Une injection de « Dépo Provera » (medroxyprogestérone) tous les trois mois
- D: Une contraception orale par oestro-progestatifs
- E: Une ligature tubaire

P	547142	
Session	Quickstart	Catalogue
Question type:	Options:	
Single Choice	5	

Patiente de 22 ans, nulligeste qui consulte en urgence suite à un rapport sexuel avec rupture de préservatif. Elle a une relation stable avec son partenaire depuis 3 ans mais ne désire en aucun cas être enceinte pour le moment. Elle n'a pas de problème de santé particulier et n'a pas d'allergie connue. L'examen physique est sans particularité.

Le test de grossesse urinaire est négatif.

Que lui proposez-vous?

- A: Répéter le test de grossesse dans une semaine
- B: Prescrire une contraception d'urgence
- C: Poser un implant contraceptif
- D: Administrer une dose de ceftriaxone intra-musculaire
- E: Administrer une dose d'azithromycine per os

Patiente de 65 ans qui consulte pour des métrorragies intermittentes depuis 3 semaines. Elle ne présente pas d'autres plaintes. Elle est ménopausée depuis l'âge de 53 ans. Elle est sous traitement de fluoxétine pour un état dépressif. Elle n'a pas d'ATCD médical. L'examen clinique est sans particularité si ce n'est la présence de traces de sang au niveau vaginal, provenant de l'orifice cervical. Il n'a pas de masse utérine ou pelvienne palpable.

Votre attitude sera:

- A: Proposer la mise en place d'un pessaire
- B: Effectuer une biopsie de l'endomètre (pipelle de Cornier) et un frottis cervico-utérin
- C: Prescrire un traitement par oestrogènes
- D: Rassurer la patiente en lui disant que ce type de saignement est normal
- E: Proposer une hystérectomie

Patiente de 55 ans qui a palpé une masse ferme dans le sein gauche. Elle se sent par ailleurs bien et ne présente pas de douleur. Elle n'a pas noté d'écoulement mammaire. Son poids est stable. Elle n'a pas d'ATCD mammaire ou d'anamnèse familiale pour un cancer du sein. Elle est ménopausée depuis l'âge de 50 ans sans traitement hormonal de substitution.

A l'examen clinique, vous retrouvez un nodule ferme de 2 cm de diamètre au niveau du QSE du sein gauche, mobile et régulier. La peau en regard est sans particularité et il n'y a aucun ganglion palpable au niveau axillaire. Vous demandez une mammographie qui est difficile d'interprétation car les seins sont très denses.

La suite de la prise en charge doit comprendre:

- A: Une biopsie échoguidée de la lésion palpée
- B: Une réassurance et une mammographie à 6 mois
- C: Une réassurance et une mammographie + US à 1 an
- D: Une réassurance et un contrôle clinique à 6 mois
- E: Une recherche de mutations des gènes BRCA 1 & 2

Jeune patiente de 16 ans qui consulte en urgence au milieu de la nuit pour des douleurs abdominales. Elle a vomi une fois le soir avant de s'endormir. Elle n'a pas de plaintes urinaires. Ses dernières règles remontent à deux semaines et étaient sans particularité. Elle ne décrit pas de leucorrhées. Elle se décrit comme sexuellement inactive. Au statut, elle est fébrile à 38.9°C et discrètement tachycarde. Sa TA est normale. Son abdomen n'est pas péritonitique mais les fosses iliaques gauche et droite sont sensibles. L'examen pelvien révèle une mobilisation du col douloureuse et une palpation bimanuelle des annexes douloureuse, surtout à droite. L'examen direct révèle la présence de nombreux leucocytes. Le test de grossesse est négatif.

Par rapport à ce tableau clinique, quel élément parle le plus en faveur d'une infection génitale haute (PID)?

- A: Une sensibilité en fosses iliaques droite et gauche
- B: Une palpation annexielle et une mobilisation cervicale douloureuses
- C: Une fièvre à 38.9°C
- D: L'absence de trouble urinaire
- E: La présence de leucocytes à l'examen direct

Etudiante de 25 ans qui présente une aménorrhée secondaire depuis un an. Elle était auparavant réglée depuis l'âge de 13 ans avec des cycles réguliers de 28 jours. Elle n'a jamais été enceinte. Elle est très sportive et vient de participer au marathon de New York pour lequel elle s'est préparée depuis plusieurs mois de façon intensive. Un test aux progestatifs était négatif il y a trois mois et vous avez éliminé une grossesse. L'examen physique est sans particularité. Elle ne présente pas de galactorrhée. Elle mesure 160 cm pour 48 kg. Le taux sanguin de prolactine est normal. Les taux de gonadotrophines FSH et LH sont par contre très bas. Le taux d'estradiol est également effondré.

La cause probable de cette aménorrhée est:

- A: Une origine hypothalamique
- B: Une tumeur hypophysaire
- C: Un syndrome des ovaires polykystiques
- D: Une ménopause précoce
- E: L'utilisation prolongée d'un stérilet